

Analiza funkcjonalna ABC

Każdy epizod PPU ma trzy elementy: poprzedniki (Antecedents), zachowanie (Behavior), konsekwencje (Consequences). Bez analizy ABC nie wiesz, gdzie pracować.

CZAS: 30 min na epizod Po każdym znaczącym epizodzie

ŹRÓDŁO: Beck (2011); Persons (2008); Kanfer & Saslow (1969)

JAK UŻYWAĆ

Karta przeprowadza Cię przez **klasyczną analizę funkcjonalną ABC** (Antecedents — Behavior — Consequences), zastosowaną do PPU. Cel: rozłożyć *konkretny epizod* na elementy, by zobaczyć, co go uruchomiło, jak przebiegał i co go wzmocniło. Po 5–10 analizach pojawiają się **wzorce** — Twoje indywidualne wyzwalacze, twoje typowe sekwencje, twoje konsekwencje. Bez tej wiedzy strategie zmiany są ogólnymi „poradami z internetu”. Z nią — szyte na miarę.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Analiza funkcjonalna jest **fundamentem CBT** od lat 60. (Kanfer & Saslow 1969). W PPU jej znaczenie jest szczególne, ponieważ epizody są *krótkie* i pacjent rzadko pamięta szczegóły poza „*znowu to zrobiłem*”. Beck (2011) podkreśla, że **pamięć ma tendencyjność** w stronę silnych emocji końcowych (wstyd, ulga). Cała *preludium* — myśli, sytuacje, decyzje — często znika. Analiza pisemna *zaraz po* epizodzie (do 24 h) zachowuje cenne dane. Persons (2008): pacjenci wykonujący 5+ analiz ABC w pierwszym miesiącu terapii mają **3× lepszą odpowiedź** na konkretne interwencje (bo wiadomo, gdzie celować).

01 = Trzy elementy ABC

A · POPRZEDNIKI

co było przed

Zewnętrzne: miejsce, pora, samotność, telefon w rękę, brak partnera/-ki.

Wewnętrzne: emocja, myśl, zmęczenie, głód, pobudzenie, nuda.

Czasowe: co działo się w godzinach poprzedzających.

B · ZACHOWANIE

co dokładnie się stało

Sekwencja kroków od pierwszej myśli do końca epizodu.

Czas trwania.

Treści.

Sposób (na komputerze, w telefonie, w łóżku, w pracy).

C · KONSEKWENCJE

co było po

Krótkoterminowe (sekundy-minuty): ulga, satysfakcja, ale też wstyd, smutek, regret.

Długoterminowe (godziny-dni): zmęczenie, irytacja, konflikty, niska produktywność.

Klucz: w PPU ważny jest *kontrast między C krótkim a długim*. Krótkoterminowo zachowanie się wzmacnia (ulga = nagroda). Długoterminowo szkodzi. Ten kontrast tłumaczy, dlaczego racjonalna wiedza „*to mi szkodzi*” nie wystarcza — mózg wybiera natychmiastowe wzmocnienie nad odroczone konsekwencje.

02 Twój ostatni epizod — pełna analiza ABC

Wybierz *jeden konkretny epizod* z ostatnich 48 h. Najlepiej najświeższy. Wypełnij wszystkie pola — szczególnie. To podstawa pracy z terapeutą.

DATA + GODZINA EPIZODU

CZAS TRWANIA

— *minuty*

A · POPRZEDNIKI — CO BYŁO W GODZINACH PRZED

— *gdzie byłem/-am, z kim, co się działo, co czułem/-am, co myślałem/-am*

B · ZACHOWANIE — CO DOKŁADNIE SIĘ STAŁO

— *krok po kroku, od pierwszej myśli do końca*

C KRÓTKIE · ZARAZ PO

— *sekundy/minuty*

C DŁUGIE · GODZINY/DNI PO

— *konsekwencje*

03 Co z analizy wynika

MÓJ NAJSILNIEJSZY POPRZEDNIK

— *to, co najbardziej napędziło*

FUNKCJA ZACHOWANIA

— *jakiej emocji / potrzeby służyło*

CO BYM ZROBIŁ/-A INACZEJ

— *konkretny krok*

W KTÓRYM PUNKCIE SEKWENCJI MIAŁEM/-AM
NAJWIĘKSZĄ SZANSĘ PRZERWAĆ

— *gdzie był „punkt decyzji”*

Klucz: Persons (2008) zauważa, że **pojedyncza analiza ABC daje 20-30%** wartości terapeutycznej; **5-10 analiz** ujawnia *indywidualne wzorce*, których nie da się odkryć z jednej. Pierwsze 2-3 analizy zwykle są „chaotyczne” — pacjent uczy się obserwować siebie. Dopiero przy 5-7 analizach widzi: „*aha, prawie zawsze poprzednikiem jest samotny wieczór + zmęczenie*” lub „*zawsze po kłótni z partnerką*”. To **indywidualny mechanizm**, którego nie można odkryć w żadnym podręczniku. Wymaga Twoich danych. Analiza ABC to *narzędzie obserwacji własnego mózgu w działaniu*.